

ETIENE SOARES

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

TESTE DE RASTREIO COGNITIVO EM IDOSOS:

FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA PROFISSIONAIS

WWW.ATIVEMEMORIAEMOVIMENTO.COM

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Soares, Etiene
Teste de rastreio cognitivo em idosos [livro eletrônico] : ferramentas essenciais para profissionais / Etiene Soares. -- 1. ed. -- Juiz de Fora, MG : Ative Memória e Movimento, 2025.
PDF

ISBN 978-65-985472-9-5

1. Idosos - Aspectos sociais 2. Idosos - Avaliação funcional 3. Idosos - Comportamento 4. Idosos - Cuidados e tratamento 5. Idosos - Saúde I. Título.

25-322533.0 CDD-362.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Idosos : Saúde e assistência : Bem-estar social 362.6

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

AGRADECIMENTO

Quero expressar minha sincera gratidão a você que adquiriu este e-book. Sua escolha em investir no aprendizado e no aprimoramento das práticas de rastreio cognitivo reflete um compromisso com a qualidade no cuidado aos idosos.

Espero que encontrem inspiração e conhecimento ao longo dessa jornada e que seja um impulso para desenvolver sua profissão com Estimulação Cognitiva em idosos. Sua escolha em investir neste Livro Digital TESTE DE RASTREIO COGNITIVO EM IDOSOS: FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA PROFISSIONAIS é um gesto que me enche de gratidão e me motiva a continuar escrevendo e compartilhando conhecimento com você.

Mais uma vez, obrigada a todos por fazerem parte dessa jornada.

Com gratidão,

Etiene Soares

APRESENTAÇÃO



Olá, meu nome é Etiene Soares. É um prazer estar aqui compartilhando meu conhecimento e experiência com você. Sou apaixonada em trabalhar com idosos e acredito que se chegou até aqui, assim como eu, você também tem essa afinidade.

Sou formada em Educação Física pela Faculdade Metodista Granbery e em Gerontologia pela Faculdade Estácio de Sá. Sou Pós-graduada em Atividades Físicas Para Grupos Especiais pela Faculdade Única, Pós-graduada em Neurociências pela Faculdade Unyleya e Membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Possuo uma formação sólida acadêmica na área do envelhecimento. Durante meus estudos, tive a oportunidade de me envolver em projetos de pesquisa e receber um prêmio do Instituto Biodelta de 3º lugar na apresentação do meu primeiro Trabalho Científico no 43º Congresso Internacional de Ciências do Esporte – Celafiscs, e no 45º Congresso Internacional de Ciências do Esporte fui convidada a

coordenar sessões de temas livres e participei de diversas atividades extracurriculares na área do envelhecimento que enriqueceram minha trajetória acadêmica.

Hoje, sou proprietária da Ative Memória e Movimento onde eu trabalho exclusivamente com idosos oferecendo Estimulação Cognitiva e Treinamento das Capacidades Físicas e Funcionais.

Espero que minhas contribuições sejam úteis e inspiradoras para todos aqueles que estão em busca de iniciar ou aprimorar o trabalho com Estimulação Cognitiva em Idosos .

Aguardo você no meu próximo E-Book.

Até lá!

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO AO RASTREIO COGNITIVO 10

1.1 Introdução 10

1.2 Importância do Rastreamento Cognitivo em Idosos 11

1.3 Princípios da Avaliação Cognitiva 11

CAPÍTULO 2

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 14

2.1 Visão Geral do MEEM 14

2.2 Aplicação do MEEM 14

2.3 Interpretação do MEEM 16

CAPÍTULO 3

TESTE DO RELÓGIO 17

3.1- Visão Geral do Teste do Relógio 17
3.2- Aplicação do Teste do Relógio 17
3.3- Interpretação do Teste do Relógio 18

CAPÍTULO 4
MOCA (MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT) 20

4.1- Visão Geral do MoCA 20
4.2- Aplicação do MoCA 20
4.3- Interpretação do MoCA 21

CAPÍTULO 5
TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL E CATEGÓRICA 23

5.1- Visão Geral do Teste de Fluência Verbal 23
5.2- Aplicação do Teste de Fluência Verbal 23
5.3- Interpretação do teste de Fluência Verbal 24

CAPÍTULO 6
ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (GDS)..... 26

6.1- Visão Geral da GDS 26
6.2- Aplicação da GDS 26
6.3- Interpretação da GDS 27

CAPÍTULO 7
INVENTÁRIO DE ANSIEDADE GERIÁTRICA..... 29

7.1 - Visão Geral do Inventário de Ansiedade 29

7.2 - Aplicação do Inventário de Ansiedade 29

7.3 - Interpretação do Inventário de Ansiedade.....30

CAPÍTULO 8
QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DE PFEFFER..... 31

8.1- Visão Geral do QAF de Pfeffer..... 31

8.2- Aplicação do QAF de Pfeffer..... 31

8.3- Interpretação QAF de Pfeffer 32

CAPÍTULO 9
ESCALA DE KATZ..... 33

9.1- Visão Geral da Escala de Katz.....33

9.2- Aplicação da Escala de Katz.....33

9.3- Interpretação da Escala de Katz.....33

CAPÍTULO 10
ESCALA CDR (CLINICAL DEMENTIA RATING)..... 35

10.1 - Visão Geral da Escala CDR 35

10.2- Aplicação da Escala CDR.....36

10.3– Interpretação da Escala CDR 37

CAPÍTULO 11
CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 38

11.1- Integração dos Resultados de Testes..... 38

11.2- Estudo de Caso 38

11.3- Recursos Adicionais 40

REFERÊNCIAS..... 42

ANEXO..... 44

FINALIZAÇÃO..... 58

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO AO RASTREIO COGNITIVO

1.1 Introdução

O envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo, incluindo o Brasil. Com o aumento da expectativa de vida, crescem também os desafios relacionados à saúde dos idosos. Um dos aspectos críticos da saúde nessa faixa etária é a função cognitiva, cuja deterioração pode levar a condições como demência e outros transtornos neurocognitivos.

Este material tem como objetivo fornecer aos profissionais da saúde uma visão abrangente sobre os principais testes de rastreamento cognitivo disponíveis, suas aplicações, vantagens e limitações. Esperamos que sirva como um recurso valioso para a prática clínica, ajudando a identificar precocemente alterações cognitivas e a planejar intervenções apropriadas.

Existem diversas ferramentas e testes disponíveis para avaliar o funcionamento cognitivo em idosos. Essas ferramentas são projetadas para medir diferentes aspectos do desempenho cognitivo, como memória, atenção, linguagem, raciocínio lógico e

funções executivas. A escolha das ferramentas e testes ade- quados dependerá dos objetivos específicos de cada profissional e da população atendida.

Alguns exames só podem ser feitos por Neuropsicólogos, mas os exames listados aqui, você como profissional pode utilizar para realizar o rastreio cognitivo em seus pacientes.

1.2 Importância do Rastreamento Cognitivo Em Idosos

Com o avanço da idade, é comum observar mudanças na função cognitiva. Essas mudanças podem ser parte do envelhecimento normal ou sinalizar o início de condições patológicas, como a demência. O rastreamento cognitivo regular permite identificar alterações sutis na cognição, facilitando intervenções precoces que podem melhorar a qualidade de vida dos idosos.

O rastreamento cognitivo é uma prática essencial na avaliação de idosos, visando identificar precocemente qualquer comprometimento cognitivo. Isso permite intervenções mais eficazes, ajudando a melhorar a qualidade de vida e o planejamento dos cuidados. O envelhecimento da população torna essa prática ainda mais relevante, pois o aumento da expectativa de vida está associado a um maior risco de declínio cognitivo.

1.3 Princípios da Avaliação Cognitiva

Existem diversas ferramentas e testes disponíveis para avaliar o funcionamento cognitivo em idosos. Essas ferramentas são projetadas para medir diferentes aspectos do desempenho cognitivo, como memória, atenção, linguagem, raciocínio lógico e funções executivas. A escolha das ferramentas e testes adequados dependerá dos objetivos específicos de cada profissional e da população atendida.

Alguns exames só podem ser feitos por Neuropsicólogos, mas os exames listados aqui, você como profissional pode utilizar para realizar o rastreio cognitivo em seus pacientes.

A avaliação cognitiva deve ser conduzida com base em princípios éticos, garantindo a sensibilidade cultural e educacional. É fundamental adaptar a abordagem às necessidades individuais, considerando fatores como nível educacional, contexto social e histórico de saúde. A avaliação não deve ser vista apenas como um diagnóstico, mas como parte integrante de um cuidado contínuo e personalizado.

1.3.1 Objetivos do Rastreamento Cognitivo

Os principais objetivos do rastreamento cognitivo incluem:

- Identificação precoce de comprometimento cognitivo.
- Diferenciação entre envelhecimento normal e patológico.
- Planejamento de intervenções adequadas.
- Monitoramento da progressão de doenças neurodegenerativas.

1.3.2 Benefícios do Rastreamento Cognitivo

Os benefícios do rastreamento cognitivo incluem:

- Intervenção precoce, que pode retardar a progressão de condições cognitivas.
- Melhor planejamento de cuidados e suporte para os idosos e suas famílias.
- Maior consciência e educação sobre saúde cognitiva entre profissionais de saúde e cuidadores.

CAPÍTULO 2

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)

2.1 Visão Geral do MEEM

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a função cognitiva em idosos. Desenvolvido para identificar demências, o MEEM avalia várias áreas cognitivas, incluindo orientação, memória, atenção, cálculo, linguagem e habilidades visuo-espaciais.

Vantagens e Limitações:

- Vantagens: Rápido, fácil de aplicar e interpretar.
- Limitações: Pode ser influenciado pelo nível educacional do paciente e não detecta alterações sutis.

2.2 Aplicação do MEEM

A aplicação do MEEM envolve a avaliação de diferentes domínios:

- **Orientação temporal e espacial:** Perguntas sobre data, hora e localização.

- **Registro:** Repetição imediata de palavras.
- **Atenção e cálculo:** Cálculos simples ou a soletração de palavras ao contrário.
- **Recordação:** Memória de curto prazo com a repetição de palavras previamente mencionadas.
- **Linguagem e habilidade construtiva:** Nomeação de objetos, repetição de frases, seguimento de comandos, escrita e desenho.

Instruções:

Ir fazendo as perguntas uma a uma e anotar tudo conforme o idoso responder sempre dando os comandos falando devagar e não ajudar em nenhuma das perguntas. Dar a pontuação conforme ele acertar. Caso ele acerte atribua nota 1 e caso não acerte atribua nota 0.

Obs.: Não anotar nada com o idoso vendo. Levante a prancheta de modo que só você veja.

O total geral máximo são 30 pontos. A escolaridade influencia diretamente na pontuação, por isso o escore é analisado para cada tipo de escolaridade. Quando a pontuação se aproxima dos 30 pontos é sinal de que o rendimento cognitivo do idoso é melhor.

Escore:

Analfabetos: 20

1 a 4 anos de escolaridade: 25

5 a 8 anos de escolaridade: 26,5

9 a 11 anos de escolaridade: 28

>11 anos de escolaridade: 29

2.3 Interpretação do MEEM

A pontuação total do MEEM varia de 0 a 30. Escores baixos podem indicar comprometimento cognitivo, mas devem ser interpretados no contexto do histórico clínico e educacional do paciente. Limitações como baixa escolaridade ou barreiras linguísticas podem influenciar os resultados.

CAPÍTULO 3

TESTE DO RELÓGIO

3.1 Visão Geral do Teste do Relógio

O Teste do Relógio é uma ferramenta simples e eficaz para avaliar funções executivas e habilidades visuo-espaciais. Ele é frequentemente utilizado em conjunto com outros testes, como o MEEM, para fornecer uma visão mais completa do estado cognitivo do paciente.

3.2 Aplicação do Teste do Relógio

O paciente é solicitado a desenhar um relógio com todos os números e ajustar os ponteiros para mostrar um horário específico. O teste avalia a capacidade de planejamento, organização e a compreensão do tempo.

Aplicação:

- Dê ao idoso uma folha de papel em branco e peça para desenhar um círculo grande, representando o relógio e colocar os ponteiros dentro.

- Em seguida, peça para colocar os números no relógio e posicionar os ponteiros e dizer, “marque 11:10h".
- É importante observar a organização dos números e dos ponteiros, bem como a precisão da marcação do horário.
- Outro aspecto que pode ser avaliado é a reprodução do desenho do relógio quando solicitado para copiar um modelo já desenhado.
- A pontuação é baseada nos critérios abaixo.

3.3 Interpretação do Teste do Relógio

Análise de correção:

Contorno	Desenho de contorno aceitável Contorno com tamanho médio	1 1
Números	De 1-12 sem adição ou omissão Só arábicos Ordem correta Papel não é rodado quando se escreve Posição correta Todos dentro do contorno	1 1 1 1 1 1

Ponteiros	Com dois ponteiros e/ou marcas	1
	Hora indicada de alguma maneira (marca)	1
	Minutos indicados de alguma maneira (marca)	1
	Na proporção correta (minutos maiores)	1
	Sem marcas supérfluas	1
	Ligados ou até 12mm de proximidade	1
Centro	Centro desenhado, inferido, ou extrapolado onde os ponteiros se encontram	1

Total = 15

Ponto de corte = 11, pontuação igual ou menor, é indício de prejuízo nessas habilidades cognitivas

CAPÍTULO 4

MOCA (MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT)

4.1 Visão Geral do MOCA

O MoCA (Montreal Cognitive Assessment) é uma ferramenta desenvolvida para detectar comprometimento cognitivo leve. Ele abrange uma ampla gama de funções cognitivas, incluindo memória, atenção, linguagem, habilidades visuo-espaciais, funções executivas, abstração e orientação.

Ele é considerado mais sensível que o MEEM para detectar comprometimento cognitivo leve.

4.2 Aplicação do MOCA

O MoCA é composto por várias tarefas que avaliam:

- **Atenção e concentração:** Tarefas de contagem e repetição.

- **Funções executivas:** Traçar uma linha alternando entre números e letras, e identificar semelhanças entre pares de palavras.
- **Memória:** Recordação de uma lista de palavras após um intervalo.
- **Linguagem:** Nomeação de animais, repetição de frases, fluência verbal.
- **Habilidades visuo-espaciais:** Desenho de figuras.
- **Orientação:** Perguntas sobre data e localização.

Preparação para a Aplicação

- **Ambiente**: Certifique-se de que o local onde o teste será administrado seja silencioso, bem iluminado e livre de distrações.
- **Material Necessário**: Você precisará de uma cópia impressa do teste MoCA, uma caneta para o paciente, e um cronômetro (opcional, para cronometrar algumas seções específicas).
- **Instruções Iniciais**: Explique ao paciente que o teste consiste em várias perguntas e tarefas curtas e que deve ser realizado da melhor forma possível, sem se preocupar em errar.

4.3 Interpretação do MOCA

A pontuação máxima do MoCA é 30, com escores abaixo de 26 sugerindo comprometimento cognitivo leve. Assim como no MEEM, a interpretação deve levar em conta o contexto educacional e cultural do paciente, bem como fatores que possam

influenciar a performance, como problemas sensoriais ou motores.

CAPÍTULO 5

TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL E CATEGÓRICA

5.1 Visão Geral do Teste de Fluência Verbal

O Teste de Fluência Verbal é utilizado para avaliar a função executiva e a memória semântica. O teste mede a capacidade do paciente de gerar palavras dentro de categorias específicas, como animais (fluência semântica) ou palavras começando com uma letra específica (fluência fonêmica).

O teste avalia o monitoramento de regras e inibição de respostas inadequadas através de fluência verbal de letras em tarefa com exigência maior das funções executivas e através da fluência verbal semântica.

5.2 Aplicação do Teste de Fluência Verbal

(FAS) - Instruir: "Diga o maior número possível de palavras que começam

com a letra “F” em 1 minuto. O idoso deve, então, tentar dizer palavras como "faca", "fogo", "festa", entre outras, em ordem rápida e não pode falar nomes próprios ou de locais e não pode falar palavras com o mesmo final. Dar um exemplo usando uma outra letra para explicar como ele deve fazer. Não interrompa e nem dê dicas. Se ele perguntar alguma coisa pede para ele dar seguimento. Quando terminar o tempo de 1 minuto pedir para ele fazer a mesma coisa com a letra “A”. Terminou o tempo pedir a mesma coisa com a letra “S”.

Anotar tudo o que o idoso fala, até os erros para dados qualitativos.

Categoria: Pedir para o idoso falar tudo o que se encontra na cozinha em 1 minuto. Quando terminar o tempo pedir para ele dizer o máximo de animais que se lembrar em 1 minuto.

5.3 Interpretação do Teste de Fluência Verbal

O número de palavras geradas é comparado a normas específicas para idade e escolaridade. Um baixo desempenho pode indicar comprometimento nas funções executivas ou na memória semântica, enquanto perseverações (repetição de palavras) ou erros de categoria podem sugerir disfunções cognitivas mais complexas.

Resultado: FAS – faz-se a somatória dos acertos de F+A+S. São considerados erros palavras com variação de sufixo ou prefixo. Considerar acerto somente a primeira palavra dita. Palavras repetidas, considerar uma como acerto e não considerar nome de pessoas.

Categórica – somar os acertos da categoria animais. Pode aceitar a variação

de gênero quando as duas palavras são diferentes, como bode e cabra. Não aceite palavras que têm apenas mudança de sufixo, como gato e gata.

Pontos de corte por escolaridade:

< 13 palavras no total do F+A+S -> para escolaridade 1-3 anos

< 20 palavras no total F+A+S -> escolaridade 4-7 anos

< 23 palavras no total F+A+S -> para escolaridade 8-11 anos

< 31 palavras no total F+A+S -> para escolaridade maior que 12 anos

Categórica: Para escolaridade acima de oito anos deve evocar pelo menos 13 pontos, abaixo de oito anos de escolaridade pelo menos 8 pontos.

No caso, quando o idoso tem a escolaridade referente e faz pontuação menor que o indicado, significa que possivelmente essa habilidade está com comprometimento.

CAPÍTULO 6

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA - VERSÃO REDUZIDA (GDS-15)

6.1 Visão Geral do GDS

A GDS tem duas versões: a GDS-15 que é versão reduzida, com 15 itens, e a GDS-30, com 30 itens com uma série de perguntas que o idoso deve responder com base em seus sentimentos e experiências nas últimas duas semanas.

Cada pergunta possui duas opções de resposta: "sim" ou "não". Cada resposta é pontuada de acordo com uma escala específica, e a pontuação total é usada para determinar a probabilidade de depressão.

Os profissionais podem considerar uma pontuação de corte específica para determinar se os sintomas indicam presença ou não de depressão.

Utilizar a versão reduzida.

6.2 Aplicação da GDS

Preparação:

- Encontre um ambiente tranquilo e confortável para a aplicação do teste, onde o idoso possa responder sem distrações.
- Garanta que o idoso tenha boa visão e audição para entender e responder às perguntas obrigatórias.
- Explique ao idoso que você irá fazer algumas perguntas sobre como ele se sente nas últimas duas semanas e que não existem respostas certas ou erradas.

Aplicação:

- Leia cada pergunta em voz alta e peça ao idoso para responder de acordo com o que melhor reflete seus sentimentos e experiências recentes.
- Cada pergunta tem duas ou três opções de resposta, com pontuações atribuídas a cada resposta. Por exemplo: "Você está satisfeito com sua vida?" Resposta: "Sim" (0 ponto), "**Não**" (1 ponto).
- A pontuação total é dada somando as respostas para todas as perguntas.
- A GDS-15 tem uma pontuação máxima de 15 pontos.

6.3 Interpretação da GDS

O escore final da GDS é usado para indicar probabilidade de depressão no idoso. Pontuações mais altas sugerem maior probabilidade de depressão.

Cada uma das respostas em negrito vale um ponto. O resultado de 5 ou

mais pontos são indicativos de sintomas depressivos, sendo que o score igual ou maior que 11 pode indicar depressão grave.

Uma pontuação alta na GDS não é suficiente para diagnosticar a depressão. É importante considerar outros fatores, histórico médico e sintomas para um diagnóstico completo.

CAPÍTULO 7

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE GERIÁTRICA

7.1 Visão Geral do Inventário de Ansiedade

O Inventário de Ansiedade Geriátrica é uma ferramenta para medir a severidade da ansiedade em idosos. Ele é adaptado para a população idosa, considerando sintomas físicos e cognitivos de ansiedade.

O inventário inclui perguntas que abrangem sintomas somáticos (como palpitações, tremores) e sintomas cognitivos (como preocupações excessivas). O paciente responde em uma escala de intensidade para cada item.

7.2 Aplicação do Inventário de Ansiedade

Pedir para o idoso responder 20 perguntas de acordo o que tem sentido na última semana com concordo se ele concorda em maior grau ou discordo se ele discorda em maior grau.

7.3 Interpretação do Inventário de Ansiedade

A pontuação total indica o nível de ansiedade, com escores mais altos sugerindo maior gravidade. A interpretação deve considerar o contexto clínico do paciente, pois condições físicas podem influenciar os resultados.

Correção: Somar todas as marcações de **concordo.**

Ponto de corte: 13 pontos para mais é indicativo de sintomas de ansiedade.

CAPÍTULO 8

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DE PFEFFER

8.1 Visão Geral do QAF de Pfeffer

O Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer avalia a capacidade do idoso de realizar atividades básicas e instrumentais da vida diária, como alimentação, higiene pessoal, uso do telefone, compras e gerenciamento de finanças.

8.2 Aplicação do QAF de Pfeffer

O PFAQ pode ser preenchido pelo próprio idoso ou por um cuidador que tenha conhecimento das atividades do idoso.

Consiste em uma lista de 10 perguntas, e para cada uma delas, é necessário indicar se o idoso consegue realizá-la sozinho, com alguma assistência ou se não consegue realizá-la.

8.3 Interpretação do QAF de Pfeffer

A escala vai de 0 a 3 e a pontuação total reflete o nível de independência funcional do idoso.

Se o score der > que 6 indica maior dependência.

CAPÍTULO 9

ESCALA DE KATZ

9.1 Visão Geral da Escala de |Katz

A Escala de Katz é utilizada para avaliar a independência do idoso em atividades da vida diária (AVDs), como banho, vestir-se, usar o banheiro, transferências, continência e alimentação.

Ela consiste nessas seis atividades básicas da vida diária (AVDs), e quando o idoso não consegue executar algumas atividades instrumentais as funções executivas estão prejudicadas.

9.2 Aplicação da Escala de Katz

A aplicação envolve a observação direta ou o relato de um cuidador sobre a capacidade do idoso de realizar essas atividades sem assistência.

9.3 Interpretação da Escala de Katz

Os escores variam de 0 a 6, com pontuações mais baixas indicando maior dependência. A Escala de Katz é uma ferramenta simples e eficaz para monitorar a independência funcional ao longo do tempo.

A avaliação total é atendida somando-se os pontos atribuídos a cada atividade, e a avaliação final ajuda a avaliar a independência funcional do idoso.

I- Independência; A- Dependência parcial; D- Dependência total.

CAPÍTULO 10

ESCALA CDR (CLINICAL DEMENTIA RATING)

10.1 Visão Geral do CDR

A Escala CDR (Clinical Dementia Rating) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a gravidade da demência em pacientes. A CDR foi desenvolvida para medir a deterioração cognitiva e funcional em seis áreas principais, proporcionando uma visão geral do impacto da demência na vida diária do paciente.

Domínios Avaliados pela CDR:

A CDR avalia seis domínios cognitivos e funcionais:

1. **Memória**: Avaliação da capacidade do paciente em reter e recordar informações.
2. **Orientação**: Avaliação da capacidade do paciente em se orientar no tempo e no espaço.
3. **Julgamento e Resolução de Problemas**: Avaliação da capacidade do paciente em tomar decisões e resolver problemas cotidianos.

4. **Função Comunitária**: Avaliação da participação do paciente em atividades fora de casa, como trabalho, compras e interações sociais.
5. **Lazer e Passatempos**: Avaliação da capacidade do paciente em se engajar em atividades de lazer e hobbies.
6. **Cuidado Pessoal**: Avaliação da capacidade do paciente em realizar atividades básicas de autocuidado, como vestir-se, alimentar-se e higiene pessoal.

1.2 Aplicação da Escala CDR

1. Entrevista com o Paciente e Informante: A aplicação da CDR envolve uma entrevista estruturada tanto com o paciente quanto com um informante que conhece bem o paciente (geralmente um membro da família ou cuidador).

2. Coleta de Informações Detalhadas: As perguntas são focadas em entender as capacidades do paciente em cada um dos domínios avaliados. O informante pode fornecer informações adicionais para áreas onde o paciente tem dificuldades em reconhecer seus próprios déficits.

3. Pontuação e Avaliação: Baseado nas respostas obtidas, cada domínio é pontuado de 0 a 3. A pontuação final ajuda a determinar o grau de demência do paciente, que pode ser usada para planejar o cuidado e o acompanhamento adequado.

1.3 Interpretação da Escala CDR

A pontuação geral da CDR é determinada pela avaliação dos seis domínios, e o paciente é classificado em uma das seguintes categorias:

- **CDR 0**: Nenhuma demência
- **CDR 0.5**: Comprometimento cognitivo leve (pode ser um estágio inicial de demência)
- **CDR 1**: Demência leve
- **CDR 2**: Demência moderada
- **CDR 3**: Demência grave

O domínio que for mais pontuado o paciente está incluído nesse grau de de

CAPÍTULO 11

CONSIDERAÇÃO FINAL

11.1 Integração dos Resultados dos Testes

Integrar os resultados de diferentes testes de rastreio cognitivo oferece uma visão abrangente das capacidades cognitivas e emocionais do idoso. Isso facilita a identificação de áreas específicas que necessitam de intervenção e permite a personalização do cuidado.

11.2 Estudo de Caso

Estudo de Caso 1: Idoso com Suspeita de Comprometimento Cognitivo Leve
Perfil do Paciente:

- Nome: José da Silva
- Idade: 72 anos
- Escolaridade: Ensino médio completo
- Histórico Médico: Hipertensão controlada, diabetes tipo 2
- Queixa Principal: Dificuldade crescente em lembrar de compromissos e tarefas diárias.

Aplicação dos Testes:

1. **MEEM:** José obteve uma pontuação de 24/30, apresentando dificuldade em questões de memória recente e cálculo.
2. **Teste do Relógio:** O relógio desenhado por José apresentava os números dispostos corretamente, mas ele posicionou os ponteiros incorretamente.
3. **MoCA:** Pontuação de 23/30, com dificuldade nas tarefas de memória e funções executivas.
4. **Teste de Fluência Verbal:** José nomeou apenas 10 animais em 60 segundos, indicando possível dificuldade em funções executivas e memória semântica.
5. **GDS:** Pontuação de 7/15, sugerindo leve depressão.
6. **Inventário de Ansiedade Geriátrica:** Pontuação moderada, indicando presença de sintomas de ansiedade.
7. **QAF de Pfeffer:** José necessitava de ajuda para gerenciar suas finanças e organizar medicações, mas era independente nas outras atividades.
8. **Escala de Katz:** Pontuação de 6/6, indicando independência total nas AVDs.

Interpretação e Planejamento de Intervenção: Os resultados sugerem comprometimento cognitivo leve, com indicativos de depressão e ansiedade que podem estar exacerbando os sintomas cognitivos. Recomenda-se intervenção psicossocial, reavaliação periódica e possível início de tratamento para depressão e ansiedade.

11.3 Recursos Adicionais

1- **Livros Recomendados:**

- "**Dementia Care: A Practical Guide**" de Bradford Dickerson e Alireza Atri – Um guia completo sobre o cuidado de pacientes com demência, com foco em abordagens práticas e intervenções baseadas em evidências.
- "**Neuropsychological Assessment**" de Muriel Lezak – Um livro fundamental para a compreensão das ferramentas e métodos de avaliação neuropsicológica.

2- **Artigos Científicos:**

- "**The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and Clinical Review**" – Um artigo que revisa o uso clínico e a eficácia do MoCA na detecção de comprometimento cognitivo.
- "**Functional Decline in Older Adults: Predicting the Importance of Cognition**" – Estudo que explora a relação entre declínio cognitivo e funcionalidade em idosos.

3- **Aplicativos e Ferramentas Digitais:**

- **MoCA Test App** – Um aplicativo que auxilia na aplicação e pontuação do teste MoCA, com recursos para armazenar os resultados de vários pacientes.
- **Cognitive Screening Toolkit** – Uma ferramenta digital que oferece uma gama de testes de rastreamento cognitivo, com suporte para múltiplos idiomas e culturas.

4- **Websites e Blogs:**

- **Alzheimer's Association (www.alz.org)** – Recurso rico em informações sobre demência, incluindo ferramentas de suporte para cuidadores e profissionais.
- **Brain Health Center (www.brainhealth.utdallas.edu)** – Recursos e programas de pesquisa voltados para a saúde cognitiva, com foco em intervenções baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

- Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research, 12*(3), 189-198.
- Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W. (1963). Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA, 185*(12), 914-919.
- Morris, J. C. (1993). The Clinical Dementia Rating (CDR): Current version and scoring rules. *Neurology, 43*(11), 2412-2414. doi:10.1212/WNL.43.11.2412
- Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. *Journal of the American Geriatrics Society, 53*(4), 695-699.
- Pfeffer, R. I., Kurosaki, T. T., Harrah, C. H., Chance, J. M., & Filos, S. (1982). Measurement of functional activities in older adults in the community. *Journal of Gerontology, 37*(3), 323-329.
- Shulman, K. I., Gold, D. P., Cohen, C. A., & Zucchero, C. A. (1993). Clock-drawing and dementia in the community: a longitudinal study. *International Journal of Geriatric Psychiatry, 8*(6), 487-496.

- Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1982). Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. *Journal of Psychiatric Research, 17*(1), 37-49.40

ANEXOS

Mini Exame do Estado Mental – MEEM (Folstein, 1975; Brucki Et al., 2003)

Nome:_____ **Data:** _____

Escolaridade: _____PONTUAÇÃO: _____

ORIENTAÇÃO TEMPORAL (5 pontos)

Dia da Semana (1 ponto) _____ _____

Dia do mês (1 ponto) _____ _____

Mês (1 ponto) _____ _____

Ano (1 ponto) _____ _____

Hora aproximada (+ ou – 1 h) (1 ponto) _____ _____

ORIENTAÇÃO ESPACIAL (5 pontos)

Local genérico (residência, hospital, clínica) (1 ponto)_____ _____

Local específico (andar ou setor) (1 ponto) _____ _____

Bairro ou rua próxima (1 ponto)_____ _____

Cidade (1 ponto) _____ _____

Estado (1 ponto) _____ _____

MEMÓRIA DE FIXAÇÃO (3 pontos)

Repetir: Carro, Vaso, Tijolo.

1 ponto para cada palavra repetida na primeira tentativa_____

_____Repita até 3 vezes caso cometa algum erro.

CÁLCULO (5 pontos)

Subtração: Sete seriado (100-7 sucessivamente), por 5 vezes

(1 ponto para cada resposta correta) (93) (86) (79) (72) (65)

_____

Qualitativo: Soletrar a palavra MUNDO de trás para frente. O D N U M (apenas qualitativo)

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO (3 pontos)

Lembrar as 3 palavras repetidas

1 ponto por palavra certa_____ _____

LINGUAGEM (8 pontos)

Nomear objetos: um relógio e uma caneta (2 pontos)

_____

Repetir: “nem aqui, nem ali, nem lá” (1ponto) _____

Seguir comando verbal: “pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão” (3 pontos) _____

Ler e seguir comando escrito (FRASE): “feche os olhos” (1 ponto) _____

Escrever uma frase (1 ponto) _____

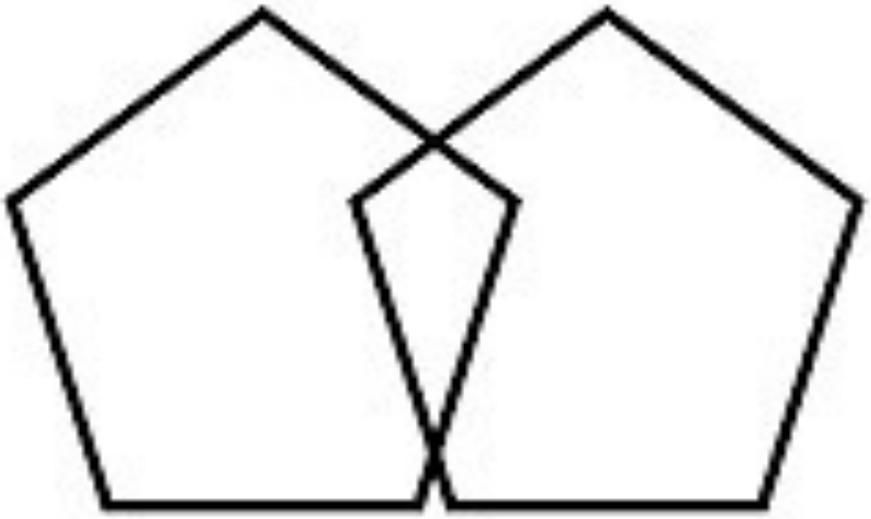
PRAXIA CONSTRUTIVA (1 ponto)

Copiar o desenho abaixo _____

TOTAL GERAL: _____(máximo 30 pontos)

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

FECHE OS OLHOS



Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – versão reduzida (GDS-15)

1	Você está satisfeito com a sua vida?	Sim/**Não**
2	Você deixou de lado muitos de suas atividades e interesses?	**Sim**/Não
3	Você sente que sua vida está vazia?	**Sim**/Não
4	Você sente-se aborrecido com frequência?	**Sim**/Não
5	Está você de bom humor na maioria das vezes?	Sim/**Não**
6	Você teme que algo de ruim lhe aconteça?	**Sim**/Não
7	Você se sente feliz na maioria das vezes?	Sim/**Não**
8	Você se sente frequentemente desamparado?	**Sim**/Não
9	Você prefere permanecer em casa a sair e fazer coisas novas?	**Sim**/Não
10	Você sente que tem mais problemas de memória que antes?	**Sim**/Não
11	Você pensa que é maravilhoso estar vivo?	Sim/**Não**
12	Você se sente inútil?	**Sim**/Não
13	Você se sente cheio de energia?	Sim/**Não**
14	Você sente que sua situação é sem esperança?	**Sim**/Não
15	Você pensa de que a maioria das pessoas estão melhores do que você?	**Sim**/Não

GDS = 15

Correção: Para cada uma das respostas em negrito o valor é 1 ponto.

O resultado de 5 ou mais pontos são indicativos de sintomas depressivos, sendo que o escore igual ou maior que 11 pode indicar depressão grave.

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE GERIÁTRICA:

		CONCORDO	DISCORDO
1	Eu me preocupo em grande parte do tempo.	O	O
2	Eu acho difícil tomar uma decisão.	O	O
3	Sinto-me agitado com frequência.	O	O
4	Eu acho difícil relaxar.	O	O
5	Eu frequentemente não consigo aproveitar as coisas por causa de minhas preocupações.	O	O
6	Pequenas coisas me aborrecem muito.	O	O
7	Eu frequentemente sinto como se tivesse um "frio na barriga".	O	O
8	Eu penso que sou preocupado.	O	O
9	Não posso deixar de preocupar-me mesmo com coisas triviais.	O	O
10	Frequentemente me sinto nervoso.	O	O
11	Meus próprios pensamentos com frequência me deixam ansioso.	O	O
12	Tenho dor de estômago por causa das minhas preocupações.	O	O
13	Eu me vejo como uma pessoa nervosa.	O	O
14	Eu sempre espero que o pior irá acontecer.	O	O
15	Frequentemente me sinto tremendo por dentro.	O	O
16	Eu acho que minhas preocupações interferem na minha vida.	O	O
17	Minhas preocupações frequentemente me oprimem.	O	O
18	Às vezes eu sinto como se tivesse um grande nó no estômago.	O	O
19	Eu perco coisas por me preocupar demais.	O	O
20	Frequentemente me sinto chateado.	O	O

Correção: Somar todas as marcações de concordo.

Ponto de corte: 13 pontos para mais é indício de sintomas de ansiedade.

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DE PFEFFER

1. Ele (Ela) manuseia seu próprio dinheiro?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de Ajuda

3= Não é capaz

2. Ele (Ela) é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho(a)?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

3. Ela (Ela) é capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

4. Ele (Ela) é capaz de preparar uma comida?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

5. Ele (Ela) é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos da Comunidade ou da vizinhança?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

6. Ele (Ela) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio ou televisão, um jornal ou uma revista?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

7. Ele (Ela) é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares, feriados?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

8. Ele (Ela) É capaz de manusear seus próprios remédios?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

9. Ele (Ela) é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

10. Ele (Ela) pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura?

0= Normal

1= Faz, com dificuldade

2= Necessita de ajuda

3= Não é capaz

Escore:_____

Escala de Atividades Básicas da Vida Diária (Katz)

1 Banho:

I. não recebe assistência

A. assistência para uma parte do corpo

D. não toma banho sozinho

2 Vestuário:

I. veste-se sem assistência

A. assistência para amarrar sapatos

D. assistência para vestir-se

3 Higiene Pessoal

I. vai ao banheiro sem assistência

A. recebe assistência para ir ao banheiro

D. não vai ao banheiro para eliminações fisiológicas

4 Transferência

I. se deita, levanta-se e se senta sem assistência

A. se deita, levanta-se e se senta com assistência

D. não se levanta da cama

5 Continência

I. controle esfincteriano completo

A. acidentes ocasionais

D. supervisão, uso de cateter ou incontinente

6 Alimentação

I. sem assistência

A. assistência para cortar carne/manteiga no pão

D. com assistência, ou sondas, ou fluidos EV

I – Independência

A - Dependência parcial

D - Dependência total

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

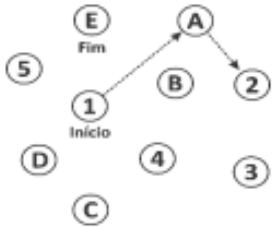
AVALIAÇÃO COGNITIVA MONTREAL - MOCA

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

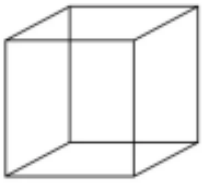
NOME:					
DATA NASCIMENTO:	___/____/_____	**IDADE:**		**SEXO:**	F ( ) M ( )
ESCOLARIDADE:			**DATA AVALIAÇÃO:**		___/____/_____

FUNÇÕES EXECUTIVAS — PONTOS

Continuar a sequência (1 ponto)



Copiar o cubo (01 ponto)



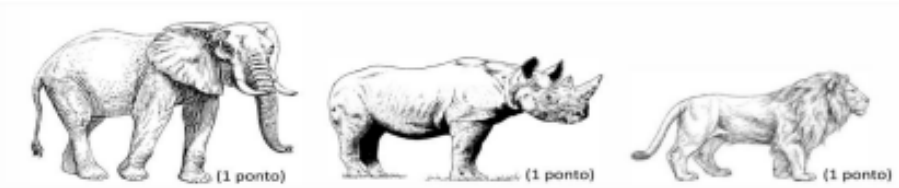
Desenhar um relógio (11:10) (3 pontos)

Contorno (1 ponto) | Número (1 ponto) | Ponteiros (1 ponto)

/6

NOMEAÇÃO — PONTOS

Que animais são esses?



/5

MEMÓRIA

Leia a lista de palavras, o sujeito deve repeti-la. Faça isso 2 vezes.

Rosto ( ) ( )	**Veludo** ( ) ( )	**Igreja** ( ) ( )	**Margarida** ( ) ( )	**Vermelho** ( ) ( )

ATENÇÃO — PONTOS

Leia a sequência de número, (1 número por segundo)

O sujeito deve repetir a sequência em **ordem direta** (1 ponto) **2 1 8 5 4**

O sujeito deve repetir a sequência em **ordem inversa** (1 ponto) **7 4 2**

Leia a série de letras. O sujeito deve bater com a mão (na mesa) cada vez que ouvir a letra "A". (1 ponto – não atribuir ponto em caso de 2 erros ou mais) **F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B**

Quanto é 100 -7? **93**	Quanto é 93 - 7? **86**	Quanto é 86 - 7? **79**	Quanto é 79 - 7? **72**	Quanto é 72-7? **65**

4 ou mais subtrações corretas: 3 pontos * 2 ou 3 corretas: 2 pontos * 1 correto: 1 ponto * nenhuma correta: nenhum ponto

/6

LINGUAGEM — PONTOS

Repetir: Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. (1 ponto)

Repetir: O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. (1 ponto)

Fluência verbal: Dizer o maior número possível de palavras que comecem pela letra F em 1 minuto. (11 ou mais palavras = 1 ponto)

/3

ABSTRAÇÃO — PONTOS

Semelhança entre, ex.: banana e laranja = fruta	**trem e bicicleta?** (1 ponto)	**Relógio e régua?** (1 ponto)

/2

EVOCAÇÃO TARDIA — PONTOS

Deve recordar as palavras **sem pistas**	**Rosto** ( )	**Veludo** ( )	**Igreja** ( )	**Margarida** ( )	**Vermelho** ( )
Pista de categorias	( )	( )	( )	( )	( )
Pista de múltiplas escolhas	( )	( )	( )	( )	( )

Pontuação apenas para evocação sem pistas, 1 ponto para cada palavra

/5

ORIENTAÇÃO — PONTOS

Dia do mês (1 ponto)	**Mês** (1 ponto)	**Ano** (1 ponto)	**Dia da semana** (1 ponto)	**Lugar** (1 ponto)	**Cidade** (1 ponto)

/6

TOTAL (Adicionar 1 ponto caso o paciente tenha 12 anos ou menos de escolaridade)

REFERÊNCIAS: Adaptado de: 1. SARMENTO, Ana Luisa Rosas. Apresentação e aplicabilidade da versão brasileira MoCA (Montreal Cognitive Assessment) para rastreio de Comprometimento Cognitivo Leve. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2009. 2. MOCA teste versão brasileira. Adaptado de www.mocatest.org. Acessado em 12/3/2018

ESCALA CDR (*CLINICAL DEMENTIA RATING*)

Nome do paciente:_____
Data da avaliação:___/___/____
Escore final categórico:_____

	Saudável CDR 0	**Demência questionável CDR 0,5**	**Demência leve CDR 1**	**Demência moderada CDR 2**	**Demência grave CDR 3**
MEMÓRIA	Sem perda de memória, ou apenas esquecimento discreto e inconsistente.	Esquecimento leve e consistente; lembrança parcial de eventos; "esquecimento benigno".	Perda de memória moderada, mais acentuada para fatos recentes; o déficit interfere com atividades do dia-a-dia.	Perda de memória grave; apenas material *muito* aprendido é retido; materiais novos são rapidamente perdidos.	Perda de memória grave; permanecem apenas fragmentos.
ORIENTAÇÃO	Plenamente orientado.	Plenamente orientado.	Dificuldade moderada com relações temporais; orientado no espaço durante o exame, mas pode ter desorientação geográfica em outros locais.	Geralmente desorientado.	Orientação pessoal apenas.
JULGAMENTO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	Resolve bem problemas do dia-a-dia, juízo crítico é bom em relação ao desempenho passado.	Leve comprometimento da solução de problemas, semelhanças e diferenças.	Dificuldade moderada da solução de problemas, semelhanças e diferenças; julgamento	Solução de problemas, semelhanças e diferenças gravemente comprometidas. Juízo social geralmente comprometido.	Incapaz de resolver problemas ou de ter qualquer juízo crítico.

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

			social geralmente mantido.		
ASSUNTOS NA COMUNIDADE	Atuação independente na função habitual de trabalho, compras, negócios, finanças e grupos sociais.	Leve dificuldade nessas atividades.	Incapaz de funcionar independentemente nessas atividades, embora ainda possa desempenhar algumas; pode parecer normal à avaliação superficial.	Sem possibilidade de desempenho fora de casa. Parece suficientemente bem para ser levado a atividades fora de casa.	Sem possibilidade de desempenho fora de casa. Parece muito doente para ser levado a atividades fora de casa.
LAR E PASSATEMPOS	Vida em casa, passatempos e interesses intelectuais mantidos.	Vida em casa, passatempos e interesses intelectuais levemente afetados.	Comprometimento levemas evidente em casa; abandono das tarefas mais difíceis; passatempos e interesses mais complicados são também abandonados.	Só realiza as tarefas mais simples. Interesses muito limitados e pouco mantidos.	Sem qualquer atividade significativa em casa.
CUIDADOS PESSOAIS	Plenamente capaz.	Plenamente capaz.	Necessita assistência ocasional.	Requer assistência no vestir e na higiene.	Requer muito auxílio nos cuidados pessoais. Geralmente incontinente.

Assinatura e carimbo do terapeuta_____

FINALIZAÇÃO

Chegamos ao final deste E-Book e é com grande satisfação que concluímos essa jornada de aprendizado juntos. O rastreio cognitivo é uma ferramenta essencial para garantir que os idosos recebam o cuidado necessário e apropriado, e espero que as informações compartilhadas aqui tenham ampliado seus conhecimentos e habilidades.

Lembre-se de que o cuidado com a saúde cognitiva dos idosos é uma responsabilidade que exige sensibilidade, paciência e, acima de tudo, conhecimento atualizado. Este e-book foi concebido para ser um recurso prático e de fácil aplicação, mas seu verdadeiro valor está na maneira como você, profissional, o utilizará no seu dia a dia.

Continuar estudando, aprimorando-se e aplicando essas ferramentas com dedicação fará toda a diferença na qualidade de vida dos idosos. O compromisso com o aprendizado contínuo é fundamental para quem deseja oferecer o melhor cuidado possível.

Agradeço por sua dedicação e desejo que este e-book seja uma fonte de inspiração e um guia útil em sua prática profissional. Que você continue a fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Muito obrigada e sucesso em sua jornada!

Atenciosamente,

Etiene Soares

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

ESPAÇO RESERVADOS PARA SUAS ANOTAÇÕES

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

ESPAÇO RESERVADOS PARA SUAS ANOTAÇÕES

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

ESPAÇO RESERVADOS PARA SUAS ANOTAÇÕES

PRÓXIMOS PASSOS

SE VOCÊ QUER... um E-book para aprender COMO COMEÇAR a trabalhar com Estimulação Cognitiva em idosos, clique no link abaixo e conheça o **MANUAL PRÁTICO PARA COMEÇAR A TRABALHAR COM ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM IDOSOS.**

- **https://www.ativememoriaemovimento.com.br/**

SE VOCÊ QUER... um treinamento em Estimulação Cognitiva em idosos, clique no link abaixo e conheça o **TREINAMENTO COMO COMEÇAR A TRABALHAR COM ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM IDOSOS.** Com vídeo aula, dicas, materiais e certificado.

- https://www.ativememoriaemovimento.com.br/curso-como-comecar

SE VOCÊ QUER... um treinamento que ensina como criar relatórios de avaliação, clique no link abaixo e conheça o **TREINAMENTO COMO CRIAR RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA IDOSOS COM DEMÊNCIA.** Com vídeo aula, dicas, materiais e certificado.

- **https://www.ativememoriaemovimento.com.br/como-criar-relatorios**

SE VOCÊ QUER... um E-book com atividades para estimular o cérebro. Clique no link abaixo e conheça **O CADERNO COM 100 ATIVIDADES PARA POTENCIALIZAR O CÉREBRO DOS IDOSOS.**

- https://www.ativememoriaemovimento.com.br/100-atividades

ATIVE MEMÓRIA E MOVIMENTO

Para saber mais informações e lançamentos de novos e-books e cursos curta nossa rede social

www.ativememoriaemovimento.com

instagram.com/ative.memoriaemovimento